

Pr Samlani 2

(0:30 - 5:02)

Bonjour tout le monde. Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est une séance de révision globale. Donc, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfait.

Donc, la séance d'aujourd'hui est une séance de révision globale, c'est-à-dire que je me suis posé la question si je devais vous faire des QCM ou des cas cliniques, et je trouvais qu'il était plus pertinent, en fait, que vous me disiez directement, en fait, les points qui vous dérangent le plus. Donc, je suis ouverte, donc on va faire cours par cours pour ceux qui restent, ceux qu'on a fait vers la fin, c'est-à-dire l'hypertension portale, c'est-à-dire la cirrhose, les pancréatites chroniques, la tuberculose et les maladies de surcharge, donc des réponses à vos questions qui vous dérangent le plus. Donc, je commencerai par l'hypertension portale.

Et donc, est-ce que vous avez des questions concernant le cours dans sa nouvelle version d'hypertension portale ? Vous avez compris la définition ? Vous avez donc, on avait dit que l'hypertension portale était un gradient entre le système porte-lavencave inférieur qui est supérieur à 5 mm de mercure ou une pression portale supérieure à 15 mm de mercure. Je vous avais expliqué que les conséquences de l'hypertension portale, c'était l'ouverture de voie de dérivation. C'était, en fait, les conséquences de l'hypertension portale étaient responsables des complications et que souvent, le diagnostic est posé parce qu'il y a ces complications qui sont symptomatiques.

C'est ça qu'il faut savoir. Et donc, ces conséquences sont l'ouverture des voies de dérivation, mais aussi les conséquences de l'hypertension portale, les conséquences de l'hypersplénisme et bien sûr, l'ascite et ses complications en elles-mêmes. Est-ce que vous avez des questions concernant ça ? Il y a quelque chose en particulier que vous n'avez pas compris ? Est-ce que vous avez compris ? Vous avez envie qu'on reprenne ensemble la physiopathologie de l'hypertension portale ? Il y avait les différents blocs.

Et là, je vois tout le monde. Les blocs préhépatiques, le bloc intrahépatique. On reprend la physiopathologie.

Je suis d'accord parce qu'en général, c'est ça qui embête. L'hypertension portale, on l'a définie comme on a dit. C'est une définition qui est, comme son nom l'indique, hypertension.

C'est une histoire de pression. La définition, c'est une augmentation de gradient de pression entre le système porte à la 24e inférieure supérieure à 5 mm de mercure ou bien une pression porte supérieure à 15 mm de mercure. Qui dit pression qui est augmentée, dit la fameuse loi d'Ohm que je vous ai née.

C'est-à-dire que la pression égale la résistance multipliée par le débit. C'est la loi d'Ohm que vous

avez fui en physiophysique. La résistance, la résistance intrahépatique et le dé, c'est le débit des vis planctoniques de toute la circulation.

Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'il y a une hypertension portale par trois mécanismes. Soit par bloc intrahépatique, quand il y a un problème au niveau du foin. C'est-à-dire qu'il va entraîner une diminution de sa circulation sanguine et bien sûr, il y aura une hypertension.

(5:02 - 10:51)

Comme quoi par exemple, comme une cirrhose, comme des métastases qui vont truffer le foin, comme une maladie de surcharge. Soit, c'est ce qu'on appelle intrahépatique, soit préhépatique ou sous-hépatique. C'est le problème qui se situe au niveau de la veine porte, bien sûr.

Ou bien post-hépatique ou suprahépatique. Le problème se situe au niveau des veines sus-hépatiques. Et donc, quand il y a un bloc, il va y avoir une augmentation de la résistance.

Parce que quand il y a un obstacle, c'est comme un tuyau d'arrosage, vous mettez le pied dessus, il va y avoir une augmentation de la résistance et il va y avoir une hyperpression portale. Et on avait dit dans le cours que quand il y a une hypertension portale, il y a une ouverture de collatéral préexistante. Ce sont des voies de dérivation entre le système porte et le système cave qui existaient dans la vie embryologiquement, mais qui ont disparu.

Mais quand le sang a besoin de passer, il cherche toutes les possibilités et ces dérivations vont s'ouvrir. Et quand ces dérivations vont s'ouvrir, ce sera responsable des varices oesophagiennes, ce sera responsable des varices gastriques, ce sera responsable des fameuses varices rectales qui seront responsables de rectorragie. Et qu'est-ce qui va se passer ? Cette hypertension portale va entraîner aussi des phénomènes humoraux, c'est-à-dire qu'il y a le monoxyde d'azote, il y a des choses qui sont vasodilatatrices qui vont être libérées pour pouvoir entraîner une vasodilatation et diminuer la tension, entraîner une hypotension artérielle.

Ça, c'est la réaction du corps à une hyperpression au niveau de la veine-porte. Sauf que quand ça se passe, il y a le rein qui va réagir. Le rein, dès qu'il détecte une hypotension artérielle, il va déclencher son fameux système rénine-angiotensine et il va y avoir une augmentation de rétention hydrocédée pour pouvoir augmenter le volume plasmatique, pour pouvoir augmenter les débits cardiaques, le débit rénal, etc.

Et c'est un cercle vicieux. Quand tout ça se fait, ça va ré-enchaîner, c'est la fameuse diapositive qu'on avait vue, une augmentation d'hypertension portale. Et le corps va réagir toujours de la même manière, augmenter plus de circulation que l'épithélial, libérer des substances vasodilatatrices.

Voilà, le rein sera encore plus sollicité. On rentre dans un cercle et avec le temps, tous les mécanismes de compensation seront usés. Et c'est là qu'on va tomber sur les complications qui

sont l'acide qui sera réfractaire.

Ça veut dire que c'est un acide qui ne va plus répondre au traitement parce que le cercle est usé. Il y aura une insuffisance rénale qui va s'installer, c'est ce qu'on appelle le syndrome hépatorénal. Et puis, quand il y aura des voies de circulation collatérales qui vont s'ouvrir, de plus en plus importantes, il va y avoir des hémorragies digestives.

Donc, c'est ça l'histoire de la physiopathologie de l'hypertension portale. Vous avez compris tout le monde ? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on a vu la classification de l'hypertension portale et on avait dit que les étiologies. Cette année, je ne suis pas rentrée dans le détail.

Vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de choses. Vous avez besoin de connaître les grandes étiologies parce que de toute façon, après, vous avez la cirrhose. Et donc, on avait dit qu'il y avait le bloc infrahépatique avec tout ce qui est obstacle au niveau de la veine-porte, que ce soit un obstacle dans la veine-porte, une thrombose ou un envahissement ou un obstacle externe, une compression et parfois des malformations congénitales.

L'obstacle intrahépatique le plus fréquent, c'est la cirrhose. C'est pour ça qu'en fait, le cours d'hypertension portale et la cirrhose ensemble parce que la cirrhose est la cause d'hypertension portale intrahépatique la plus fréquente. Et les étiologies de la cirrhose les plus fréquentes, ce sont l'alcool, les hépatites, mais aussi il y a les maladies, donc les cirrhoses biliaires, les cirrhoses auto-immunes et les maladies de surcharge.

Et il y a plein d'autres étiologies comme les hyperplasies nodulaires, les hépatites aiguës, tout ce qui est surcharge, etc. Et ce qu'il faut aussi que vous connaissiez, que vous rappeliez, c'est le syndrome de Bulgari parce que c'est quelque chose que le généraliste doit connaître, c'est-à-dire que même si le nom paraît un petit peu barbare, il faut juste se rappeler que c'est une étiologie très fréquente, donc aussi de l'hypertension portale. Et c'est l'obstruction au niveau des voies de retour vénéhépatique, ça veut dire au niveau des veines sucépathiques ou bien parfois quand il y a un obstacle au niveau de la veine cap ou bien l'insuffisance cardiaque droite, il va y avoir en fait, quoi quand il y a un obstacle ? Il va y avoir une hyperpression en amont, c'est-à-dire au niveau du foie et ça peut donc soit se manifester dans la forme aiguë par une douleur qui est intense, pourquoi ? Parce qu'il y a une turgescence, parce qu'il y a donc un reflux de sang dans le foie, soit ça peut entraîner à terme une cirrhose parce qu'il va y avoir une souffrance de ces hépatocytes qui n'arrivent pas à... voilà, parce qu'il n'y a pas... il y a un obstacle à ce niveau-là, donc il y aura une souffrance des hépatocytes.

Et donc, il y a deux types de syndrome de bucciarì, le syndrome de bucciarì aigu, le syndrome de bucciarì chronique qui se manifeste ou ressemble à une cirrhose et qui est une étiologie de cirrhose. C'est important à savoir parce que c'est fréquent et parce que beaucoup de généralistes feront de l'échographie et ils devront, quand ils verront le foie, étudier le foie, voir aussi les veines suisses hépatiques. Et donc, quand on a vu la physiopathologie, une fois qu'on a compris la

physiopathologie, on a compris que les circonstances de découverte ou bien de l'hypertension portale, ce sont les complications.

(10:51 - 11:34)

Les complications, c'est-à-dire la CIT, la circulation collatérale, la splénomégalie que vous allez retrouver à l'examen et les signes en rapport avec l'éthiologie. Et donc, c'est pour ça que quand vous allez faire une numération formule sanguine, quand vous pouvez trouver une pancytopénie parce qu'il y a la rate qui va manger en fait les lignées, à l'endoscopie, vous allez chercher les varices, les varices grade 1, grade 2, grade 3, les varices gastriques ou la gastropathie d'hypertension portale. Et c'est l'échographie qui est un examen qui est important puisqu'elle va rechercher la dilatation du trou de porte, les dérivations, les fameuses dérivations portocave, donc les dérivations, la splénomégalie, la CIT et bien sûr, étudiera toujours les veines suisses hépatiques.

(11:35 - 12:42)

Et je vous avais mis dans le cours beaucoup d'images. Alors, les complications que vous devez connaître, c'est les hémorragies digestives qui peuvent être extériorisées ou pas. Ça aussi, c'est un petit détail qui est intéressant.

Une hémorragie digestive peut être extériorisée quand elle est haute par des hématemèses, par des méléna, mais aussi par une anémie. L'acide et il y a aussi l'infection de liquide d'acide qui complique en fait cet acide. Et l'infection de liquide d'acide est une urgence qui peut se manifester par des douleurs, par une fièvre, par une diarrhée.

Et donc, c'est la fonction de liquide d'acide qui va rechercher le nombre de polycléanophilies quand il est supérieur à 250. C'est un chiffre important, on parle d'infection liquide d'acide. Le syndrome hépatorénal qui est la conséquence de l'insuffisance rénale et l'encéphalopathie hépatique.

Et le traitement en fait, ce sera un traitement essentiellement des complications. Pour l'hémorragie digestive, ce sera les vasoactifs et ce sera le traitement endoscopique. Pour l'acide, ce sera les diurétiques, les ponctions, voire la transplantation hépatique.

(12:42 - 13:34)

Et donc, pour la surinfection liquide d'acide, ce sera bien sûr les ponctions, les antibiotiques. Donc, je pense que l'hypertension portale, ça a été allégé cette année. C'est plus simple et c'est plus clair.

Donc, on va attaquer maintenant la cirrhose. Est-ce que vous avez des questions concernant la cirrhose ? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, pour lesquelles vous vouliez avoir un contact direct avec moi ? En principe, c'est basique aussi. La définition que je

vous ai mise cette année aussi, c'est très allégé.

Je vous ai mis la définition anapathie, atteint diffus du foie associant une fibrose annulaire de nodule de régénération. Je voulais aussi que vous vous rappeliez que la cirrhose, c'est une histoire d'anapathie, puisque c'est la fibrose de nodule de régénération. Le diagnostic de certitude est un diagnostic qui est histologique.

(13:35 - 22:35)

C'est un élément important à se rappeler. Et je voulais aussi que vous sachiez que c'était l'évolution ultime de beaucoup de pathologies. Tout ce qui va agresser le foie risque d'entraîner une hépatite aiguë, puis une hépatite chronique si l'agression continue, puis à terme, une destruction du parenchyme hépatique avec de la fibrose, parce que vous vous rappelez qu'il y a de l'inflammation et l'inflammation peut évoluer, bien sûr, vers de la fibrose.

Et dans ce cas-là, il y a de la cirrhose. Et je vous avais montré deux aspects dans votre cours. L'aspect macroscopique d'un foie normal, l'aspect d'un foie cirrhotique.

Et c'est parce que le foie cirrhotique ressemble à ce que je vous avais montré. Ça veut dire un foie qui est bosselé, qui est granuleux en surface avec un bord inférieur tranchant. Ce sont les choses que vous, à l'examen clinique, vous allez rechercher.

Ma question, est-ce que vous aurez toujours une hépatomégalie au cours d'une cirrhose? Est-ce qu'il y a toujours une hépatomégalie au cours d'une cirrhose? Qu'est-ce qu'on peut avoir au cours de la cirrhose? Oui, on peut avoir un gros foie, parce qu'il y a, simplement réfléchissez, on peut avoir un gros foie qui est déformé parce qu'il y a de la fibrose et parce qu'il y a de la chose. Comme on peut avoir un foie qui est atrophique. Comme on peut avoir une partie du foie qui est atrophique, une autre partie qui est hypertrophique.

Donc, on ne trouve pas, vous avez tout à fait raison, pas toujours une hépatomégalie. La flèche hépatique peut être normale, comme elle peut être augmentée, comme elle peut être même diminuée. Ce qui est important, c'est, et ça vous l'avez vu en sémiologie, c'est palper, voir la surface, si elle est granuleuse, voir si elle est dure, voir le bord inférieur si il est tranchant.

Et c'est surtout, en fait, c'est l'intérêt de l'échographie qui va montrer cet aspect qui est lobulé, qui est bosselé et qui va montrer les signes d'hypertension portale. Et le diagnostic, c'est un diagnostic de cirrhose, là aussi c'est un élément que je voudrais que vous sachiez, vous vous rappeliez. Le diagnostic peut être posé de deux manières, soit directement par la biopsie hépatique, soit sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, endoscopiques et avec maintenant l'avènement des tests invasifs, non-invasifs, je veux dire, depuis de nombreuses années.

C'est-à-dire qu'avant, peut-être qu'il y a trente ans ou quarante ans, pour poser le diagnostic

d'une cirrhose, il fallait faire la biopsie. Après, on a compris qu'on pouvait poser le diagnostic avec, à l'interrogatoire, en recherchant, en trouvant des signes d'hypertension portale, à la biologie, quand on trouve des signes en faveur d'un hypersténisme, un taux de plaquette qui est diminué, à l'endoscopie, si on trouve des varices oesophagiennes, à l'échographie, si on trouve des éléments en faveur d'une hypertension portale, on peut être orienté, devant tout ça, vers un diagnostic qui est celui d'une cirrhose. Et, bien sûr, il y a les tests non-invasifs que je vous ai donnés cette année, un petit peu plus approfondis.

Ce sont... voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un coup d'insuffisance hépatocellulaire, l'hypocratisme digital, les ongles blancs, les ongles homestellaires ? Alors, il faut savoir que l'hypocratisme digital, on ne le trouve pas uniquement d'insuffisance hépatocellulaire. L'autre jour, j'avais une patiente qui avait un cancer du poumon, sous chimiothérapie, et j'ai regardé ses doigts et j'ai vu qu'elle avait l'hypocratisme digital, au cours des maladies chroniques.

Au cours des maladies chroniques et quand il y a des soucis, en fait, de vascularisation et, bien sûr, d'oxygénation, on peut trouver des complications, des choses, des manifestations telles que l'hypocratisme digital. Par contre, les ongles homestellaires, c'est qu'au cours de l'insuffisance hépatocellulaire... Attendez une seconde. Au cours de l'insuffisance hépatocellulaire, on a des troubles hormonaux.

Et donc, on aura des troubles hormonaux avec une peau qui sera plus fine et il y aura, bien sûr, des enjeux homestellaires, des signes cutanés, des enjeux homestellaires, des taches rubies qui seront donc des conséquences des troubles hormonaux. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière pour avoir une atrophie dans la cirrhose ? C'est qu'au stade ultime de fibrose, quand la fibrose est très évoluée et qu'elle part en chimie, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de sang, le foie va s'atrophier parce que c'est une boule en fait de fibrose. Donc, il y aura de l'atrophie.

C'est la raison pour laquelle il y a de l'atrophie au cours de la cirrhose. Donc, pour revenir à la cirrhose, il y a deux formes de cirrhose. Il y a la cirrhose non compensée et la cirrhose qui n'est pas décompensée, la cirrhose décompensée.

Et je vous avais expliqué dans le cours que pendant longtemps, la cirrhose peut être compensée et le cirrhotique peut être comme vous et moi. C'est-à-dire quelqu'un qui a une hépatite virale C ou bien quelqu'un chronique qui évolue à la cirrhose à bas bruit ou quelqu'un qui est alcoolique chronique qui évolue à la cirrhose à bas bruit. Il peut très bien être bien portant, debout, sans problème, exercer une activité physique.

Puis, petit à petit, il commence à manifester des signes donc d'insuffisance hépatocellulaire et des signes d'hypertension portale. Les signes d'insuffisance hépatocellulaire, le premier signe en général que les gens ressentent, c'est l'asthénie. Ils commencent à avoir une fatigue importante.

Après, viennent les autres signes petit à petit. Et ensuite, il y a des signes d'hypertension portale. Et dans ce cas-là, c'est l'acide, l'hémorragie digestive et l'encéphalopathie hépatique.

Donc, un cirrhotique n'est pas toujours quelqu'un qui vomit du sang, qui a de l'acide et qui est allongé. Il peut très bien y avoir un cirrhotique qu'on dit compensé, une cirrhose qui est compensée, donc quelqu'un qui est comme vous et moi. C'est juste qu'avec l'insuffisance hépatocellulaire, il peut se fatiguer petit à petit.

Donc, c'est pour ça qu'il faut différencier la cirrhose non décompensée, où il n'y a aucun signe fonctionnel carrément, ça peut durer de 1 an à 10 ans, à la cirrhose qui est décompensée par l'acide ou bien compliquée par l'hémorragie digestive où il y a une encéphalopathie hépatique. Et dans ce cas-là, ce qu'on cherche essentiellement, c'est les signes d'insuffisance hépatocellulaire, l'asthénie, c'est le signe le plus précoce, l'encéphalopathie, le fœtor hépaticus, rappelez-vous votre cours de sémiologie, les enjômes stellaires, les ritroses palmaires, les ongles blancs et des signes endocriniens, des syndromes hémorragiques. Et à la biologie, c'est ce qu'on a dit, c'est l'anémie parce qu'il y a la pancytopénie, la leukopénie, la thrombopénie et les signes d'insuffisance hépatocellulaire, la baisse du TP, du facteur 5 et l'hypoalbuminémie.

Et je vous ai mis un élément important dans le cours, j'ai jugé que c'était important parce qu'avant ça passait plutôt rapidement, c'est l'apport de l'échographie dans le diagnostic mais aussi dans le suivi de la cirrhose. Il est important de répéter les échographies tous les six mois pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire. C'est un élément qui est très important.

L'échographie du cirrhotique, chez le cirrhotique, il est important de faire des échographies tous les six mois pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire. Alors, je vous ai mis cette année l'évaluation pronostique par le TCHAL. L'asthénie de tous les jours, ça c'est les gens qui préparent.

L'asthénie, comment différencier de l'asthénie la fatigue de tous les jours et l'asthénie de l'insuffisance hépatocellulaire. C'est une asthénie qui est importante. Vous savez, on n'est pas supposé être fatigué tous les jours.

On est fatigué après un travail, après un effort. En général, c'est quand on se réveille le matin, on n'est pas fatigué. Si on est fatigué le matin, c'est bien problème.

On se réveille le matin, on est bien, on travaille la journée. Si on a travaillé, on est parti à l'hôpital, on a fait le cours l'après-midi, on a révisé, on est sorti faire des courses, on a vu des amis et le soir, on rentre, on est fatigué, c'est normal. Par contre, lorsque la personne, votre patient vous dit qu'il est fatigué plus qu'avant, que c'est fatigué, commence dès le matin et l'empêche de faire ce qu'il avait l'habitude de faire, là, il faut se poser la question.

C'est-à-dire que c'est une asthénie qui l'empêche de vaquer à des occupations normales, c'est-à-dire de travailler, de faire les cours, de s'occuper de ses enfants. C'est une asthénie qui est dérangeante. C'est là où il faut explorer.

(22:37 - 24:12)

Donc, évaluation pronostique, je vous ai parlé du child et je vous avais dit, c'est quelque chose qui se répète tout le temps, c'est un score qui repose sur des éléments cliniques, sur des éléments biologiques. Les éléments cliniques, c'est l'encéphalopathie, l'acide biologique, c'est la bilirubinabuminato de prothrombine. Et je vous avais dit que ce child, il a un intérêt, c'est qu'il a une évaluation pronostique, c'est-à-dire que chez un chiotique, on l'utilise le premier jour où vous le voyez et après, on est toujours en train de calculer le child.

On peut passer d'un child A à un child B et dans ce cas-là, on sait qu'il s'est compliqué. Comme on peut passer d'un child C, par exemple, où il y a de l'acide, à un child B ou un child A, on sait qu'on a amélioré le patient. Donc, c'est un score qui est pronostique.

Et le deuxième score, c'est le score de MELT. Le score de MELT, c'est un score que vous pouvez calculer sur votre téléphone. Il y a une application, vous rentrez, vous cherchez maintenant, vous êtes connecté, MELT.

Et une fois que vous allez trouver MELT, vous allez mettre en fait les éléments. On a besoin de la bilirubine, la créatine, les NINR et on peut calculer le MELT. Et ce MELT-là, il a un intérêt pour, essentiellement, il a un intérêt aussi pronostique.

Il a un intérêt parce qu'il est corrélé quand il est très élevé à la survie, d'une part. Et d'autre part, si on veut mettre les patients dans des listes de transplantation, on a besoin d'avoir le MELT parce que c'est en fonction du MELT, en fait, qu'on priorise les patients pour la transplantation hépatique. Donc, deux scores à se rappeler pour la cirrhose, le score de CHILD et le score de MELT.

(24:13 - 35:43)

Alors, pour la cirrhose, je vous ai mis des étiologies vraiment très simples. Je vous ai parlé d'alcool, d'hépatite virale, stéatohépatite non-alcoolique et autres, les maladies auto-immunes, maladies cholestatiques et maladies de surcharge. Donc, je vous demanderai de les connaître parce que c'est vraiment le basique du basique.

Il y a 4 ou 5 choses à connaître. Alors, quoi d'autre ? Pour la tuberculose, c'est extrêmement simple. La tuberculose est un cours qui fait peur peut-être parce que... Qu'est-ce qu'on fait chez nous ? Oui, on fait la transplantation hépatique.

On fait la transplantation marrakech et le seul CHU qui a fait je pense 5 ou 6 transplantations hépatiques. Je suis personnellement 3 de mes patients qui sont transplantés du choix, qui sont vivants et qui vont bien. Il y a eu des enfants aussi qui ont été transplantés du choix.

La particularité de la transplantation hépatique chez nous, c'est qu'on la fait avec d'honneur

vivant, c'est-à-dire que c'est un membre de la famille qui va donner une partie de son foie. Et oui, on fait la transplantation hépatique chez nous. Ça va être que les conditions sont encore en cours de préparation, etc.

Mais on fait la transplantation hépatique et on a des cas qui sont vivants et qui vont bien. Donc, la tuberculose abdominale est un cours qui peut peut-être vous faire peur, mais il est extrêmement simple. Et je voulais simplifier encore un petit peu plus cette année.

Donc, la tuberculose, des choses que je voulais que vous connaissiez dans la tuberculose, c'est la physiopathologie qui est très important pour vous de la connaître, c'est-à-dire que c'est un bacille qui est acido-alcool-résistant, dont l'ADN. Alors, est-ce que l'encéphalopathie hépatique ne régresse pas si elle apparaît? Si, elle régresse. Elle régresse parce que si on trouve l'éthiologie.

Vous savez, je donne souvent une comparaison de la cirrhose. La cirrhose, c'est un état qui est précaire. Vous savez, qu'est-ce que c'est qui est précaire? C'est un état qui est fragile, c'est-à-dire que n'importe quoi peut le déséquilibrer.

La précarité, c'est ça. C'est un état qui est fragile, n'importe quoi peut le déséquilibrer. Donc, vous avez un cirrhotique et il fait une infection, il peut faire de l'encéphalopathie hépatique, faire une décompensation acétique.

Vous avez un cirrhotique et il prend, je ne sais pas moi, une drogue ou un diurétique ou un somnifère, il peut faire aussi une encéphalopathie hépatique. Mais si on lève le facteur déclenchant, cette encéphalopathie peut régresser. C'est variable, ce n'est pas toujours gagné, mais si on trouve un facteur déclenchant et qu'on le lève, cette encéphalopathie peut régresser.

Un cirrhotique qui a saigné de ses varices oesophagiennes peut aussi tomber en encéphalopathie hépatique. Si on contrôle l'hémorragie, cette encéphalopathie peut régresser. D'accord ? C'est bon pour la cirrhose et l'hypertension portale ? Donc, on passe rapidement à la tuberculose.

La tuberculose, je voudrais que vous insistiez sur la physiopathologie parce que c'est important, que vous sachiez, ça vous l'avez fait dans d'autres cours, je pense, infectieuse et pneumologie. Ce qui m'intéresse moi surtout pour la tuberculose abdominale, parce que je vous parle de la tuberculose abdominale, pas digestive, c'est que les voies de cheminement sont multiples. On a la voie hématogène par le sang où il va y avoir une atteinte du péricitone, des ganglions, etc.

La voie lymphatique avec les ganglions, la voie digestive endogène ou exogène. Endogène, c'est-à-dire quand on mange quelque chose qui est contaminé, ou bien exogène plutôt quand on mange quelque chose qui est contaminé, endogène quand on le déglutit, et la contiguïté en cas de tuberculogénite. Alors, je voulais aussi que vous sachiez que ce qui est plus important pour nous, c'est l'acide, la tuberculose péritoneale dans sa forme acidique, parce que pourquoi ?

Parce que c'est la plus fréquente et qu'elle demeure fréquente, et que toutes les semaines on en trouve, que les circonstances découvertes peuvent être multiples, soit que la symptomatologie est liée à l'acide, quand il y a une douleur abdominale, une distension, soit des signes d'imprégnation tuberculeuse, le fébricule, l'amaigrissement, etc.

Et qu'on peut trouver un tableau d'acide libre comme on peut trouver un tableau d'acide cloisonné en damier. Et pas plus tard que cette semaine, donc j'ai diagnostiqué un monsieur qui avait une tuberculose péritoneale, et je l'ai suspecté. Pourquoi ? Parce qu'à l'examen, déjà cliniquement, quand je percute, j'ai une matité en damier, et quand, même après avoir fait l'échographie et un autre examen d'imagerie, quand je ponctionne, l'acide n'est pas libre, et que la ponction d'acide ne donne pas beaucoup parce que l'acide est cloisonné.

Et donc, j'ai fait l'adénosine des aminases dans le liquide d'acide, de même bien sûr que l'étude chimique, c'était une acide qui était riche en protides avec une adénosine des aminases qui était très élevée. Et donc, j'ai posé le diagnostic de tuberculose péritoneale. Donc, la forme la plus fréquente pour moi, c'est la tuberculose péritoneale dans sa forme acétique isolée.

Et donc, pour celle-ci, il est important que vous connaissiez en fait l'aspect du liquide d'acide qui est jaune citron, qui est riche en protides avec une prédominance lymphocytaire. C'est des choses qu'on voit tous les jours. Quand je fais ma ponction d'acide, j'étudie ça.

Et je fais bien sûr le dosage de l'adénosine des aminases qui a une excellente sensibilité spécifique. Voilà. Donc, il faut aussi que vous sachiez que le liquide de tuberculose est un liquide qui est possibacilaire, c'est-à-dire que vous aurez très peu de chances de trouver des bacilles dedans et que la culture, elle est tardive, mais qu'on peut bien sûr chercher l'adénosine des aminases ou bien la perpéron gamma dans ce liquide.

Alors, l'échographie est importante. Autre chose que je voulais que vous sachiez, c'est que les diagnostics différentiels, quand on vous les demande, restez toujours sémiologiste. Quand vous êtes face à une acide, rappelez-vous ce qu'on avait dit.

C'est une acide, quand c'est une acide tout court, on pense à toutes les étiologies de l'acide, que ce soit la carcinose, que ce soit la cardiaque, que ce soit la suissance rénale, que ce soit n'importe quoi, mais dès que vous savez que c'est une acide qui est riche en protines, vous pensez à la néoplasique et vous pensez bien sûr à une acide qui est d'origine cardiaque, d'origine pancréatique. Alors, il y a les autres formes cliniques, ce sont les formes évolutives, la fameuse granulie. La granulie, c'est l'équivalent du milliard dans le peritoine qui prédomine chez l'enfant et qui est douloureuse.

Il y a une forme qui est anacétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acide, il y a très peu d'acide. Et il y a les formes chroniques, les formes uséro-caséuses, les formes fibro-adhésives où il y a beaucoup de fibroses, où les deux feuillets du peritoine vous collent et il y aura un aspect qui est encapsulé. Alors, rappelez-vous aussi que c'est pour ça qu'on fait la tuberculose abdominale

parce qu'il n'y a pas que la tuberculose péritoneale, il y a une tuberculose intestinale qui peut se manifester par des ulcérations qui peuvent se perforer ou par une occlusion.

Il y a la tuberculose colique, il y a aussi la tuberculose anopérinéale qui est un diagnostic qu'on voit pour tout ce qui est fistule et tout ce qui est maladie de Crohn. Il y a aussi, elles existent, les tuberculoses de la rate, les spléniques, les tuberculoses hépatiques, les tuberculoses pancréatiques, les tuberculoses gastriques. Donc, si on fait ce cours, c'est que vous sachiez que la tuberculose peut toucher en fait tout l'abdomen et qu'elle peut avoir de multiples aspects.

Et donc, vous restez toujours carré, vous faites votre examen, vous faites des prélèvements s'il y a des prélèvements à faire, s'il y a du liquide d'acide, vous faites des aminases dessus, vous pouvez user l'interféron gamma et puis des fois, malheureusement, vous n'avez rien et vous passez à ce qu'on appelle la cellule exploratrice où vous avez un aspect qui est très caractéristique. Je vous ai montré une photo dans le cours et il faut faire bien sûr des biopsies. Donc, c'est extrêmement simple.

Le traitement antituberculeux, il est codifié. Il est donc, c'est un programme national de lutte antituberculeuse que vous allez voir, que vous connaissez peut-être mieux que moi. Sachez juste que pour la tuberculose abdominale, quand c'est compliqué, on peut utiliser du traitement chirurgical et du traitement symptomatique et que donc, il faut toujours, l'essentiel en fait dans la tuberculose pour pouvoir l'éradiquer, c'est la prévention et c'est améliorer la qualité de vie des patients et de la population.

Donc, la tuberculose, c'est extrêmement simple. Si vous aurez des questions, vous aurez des questions sur basique, donc sur les localisations, sur l'aspect de l'acide, sur la manière de poser le diagnostic, il n'y aura jamais de piège. En tout cas, pas attentionné.

Donc, est-ce que vous avez des questions sur autre chose ? La proctologie, c'est basique, là aussi. Je vous ai mis la maladie hémorroïdaire, je vous ai mis la fissure et les fistules. Pour la proctologie, la fistule, c'est extrêmement simple, c'est voilà, il faut juste savoir qu'il y a des fistules qui sont complexes et je vous ai mis une définition qui est extrêmement simple des fistules complexes.

Et puis, la maladie hémorroïdaire, c'est extrêmement simple également. Un cordon, voilà, ça c'est la question que j'aime bien parce que nous, on a l'habitude d'utiliser ce jargon, mais on ne sait pas que ça vous dérange. Alors, un cordon, c'est un cordon, c'est-à-dire que quand moi je palpe, j'ai une fissure, j'ai une fistule, pardon, un orifice fistuleux externe et je fais mon examen clinique.

Quand je fais mon examen clinique, je commence par faire, comme l'examen abdominal, une inspection, puis une palpation, puis un toucher anal, puis un toucher rectal, avant de poser l'anuscopie, sachant que poser un anuscope fait partie des compétences d'un médecin généraliste. Donc, quand, j'arrive, je finis avec madame et on verra. Alors, un cordon, c'est quoi ?

C'est quand, moi, je trouve l'orifice fistuleux externe et que je veux le rattacher à l'anūs, je palpe avec le doigt.

(35:44 - 36:14)

Et quand je palpe avec le doigt et que je trouve quelque chose qui est dur, comme un cordon, entre l'orifice fistuleux et l'anūs, je sais qu'il y a une communication sous le doigt. Et c'est à travers, en fait, ce cordon qu'il y a issue depuis. Et donc, c'est cet endroit, ce cordon-là que je vais cathéteriser à travers l'orifice interne, c'est-à-dire que je vais mettre un stylet, une sorte de petit bâtonnet en métal, dans l'orifice interne pour passer dans l'orifice externe et pouvoir faire ma chirurgie.

(36:15 - 36:28)

Donc, c'est ça le cordon. Le cordon, c'est un indice qui montre que l'orifice externe est connecté à un orifice interne qui est intra-anal. Vous avez compris, Nourayla ? Donc, c'est à la palpation, c'est un cordon.

(36:29 - 37:25)

Vraiment, je le sens comme une petite induration. C'est une induration entre l'orifice externe et l'orifice interne. Alors, autre question.

Nourayla, vous avez compris ? Ou je dois répéter ou expliquer différemment ? Il n'y a pas de mal, dites-moi. Alors, est-ce qu'une fistule recto-anal doit faire rechercher systématiquement une maladie de Crohn ? Une fistule recto-anal. Qu'est-ce que vous voulez dire par une fistule recto-anal ? Une fistule anal.

Une fistule anal doit faire rechercher systématiquement une maladie de Crohn. Dans le cours, c'est ça que vous voulez dire ? C'est pas la peau cartonnée. La peau cartonnée, non, pardon, je continue avec Nourayla.

(37:25 - 37:51)

La peau cartonnée, c'est vague. Un cordon, c'est vraiment comme si vous aviez, vous savez, une sorte d'élastique sous la peau. Et il est un cordon, pas le cordon des rideaux.

Un cordon des rideaux. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez un truc qui est longitudinal, qu'on sent sous le doigt et qui est limité.

(37:51 - 38:08)

La peau cartonnée, c'est mal limité. Un cordon, c'est vraiment quelque chose comme un cordon. Un cordon que vous voyez de rideaux, quelque chose, mais qui est sous la peau, qui est comme le rêpe entre l'orifice externe et l'orifice interne.

(38:10 - 38:27)

Alors, une fistule anal doit faire rechercher une maladie de Crohn ? Systématiquement, non. Une fistule anal ne doit pas faire rechercher systématiquement une maladie de Crohn. Alors, une fistule anal peut avoir un aspect qui est de fistule, on dit, simple.

(38:28 - 38:40)

C'est-à-dire que c'est un seul orifice externe chez quelqu'un qui est bien portant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ulcération associée, il n'y a rien du tout. On peut l'opérer simplement sans se casser la tête.

(38:40 - 39:21)

Par contre, quand on a une fistule complexe, plein d'orifices externes, associées soit dans un contexte clinique qui est particulier, quand vous avez quelqu'un qui a une diarrhée, qui a un syndrome de Koenig, vous avez fait le cours des maladies inflammatoires chroniques intestinales, syndrome de Koenig, c'est syndrome d'obstruction intestinale, et que vous avez une fistule associée, là, vous pensez, bien sûr, à quelque chose qui est spécifique, soit à une maladie de Crohn, soit aussi à une tuberculose. Voilà. Et on sait que pour la maladie de Crohn, les manifestations anopérinéales, généralement, ce n'est pas une seule fistule, il y en a beaucoup.

(39:21 - 39:52)

Et souvent, on a aussi des associations de manifestations anopérinéales, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs fistules associées à des ulcérations, à des fissures qui ont cette particularité, qu'elles ne sont pas polaires postérieures mais qu'elles sont latéralisées, qui sont à berges à tonnes. Vous savez ce que c'est des berges à tonnes ? Les fissures simples, vous l'avez dans le cours, ce sont des fissures qui sont en raquettes, qui sont toutes mignonnes. Par contre, les fissures qui sont spécifiques, elles sont à berges à tonnes, c'est-à-dire des berges qui sont comme déchiquetées, qui n'ont pas de forme, et qui, en général, ne sont pas douloureuses.

(39:53 - 40:22)

Là, on pense à une maladie de Crohn, effectivement. On peut penser à une maladie de Crohn, mais de toute façon, il faut faire des explorations, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas d'antibiotiques en cas de fistule anal, à votre avis ? C'est quoi le traitement de la fistule anal ? Oui, M ? Quel est le traitement de la fistule anal ? Oui, M ? Le traitement de la fistule anal, c'est quoi ? Le traitement, il y en a un seul.

(40:26 - 40:36)

C'est le traitement chirurgical. Donc, si je donne... Ça, c'est pour parler à votre collègue, Noheila.

Si je donne des antibiotiques, je risque de fermer le cordon.

(40:37 - 40:47)

Les antibiotiques vont, peut-être, assécher le pus. Donc, fermer ou faire disparaître ce cordon. Et je ne peux plus faire un traitement chirurgical comme il faut.

(40:48 - 41:02)

Parce que ce cordon-là, c'est comme une petite française. C'est ça, en fait, qui me donne la possibilité de faire un traitement correct, de cathéteriser et d'enlever tout le trajet de la fistule. Donc, on ne donne pas d'antibiotiques, on traite chirurgicalement.

(41:02 - 41:27)

On peut donner par la suite, après avoir fait un drainage, des antibiotiques, mais pas uniquement et pas d'emblée. OK ? Parce que le traitement de la fistule anal est un traitement qui est chirurgical. Sauf, bien sûr, dans le cas de la maille de Crohn, où le traitement est un drainage, ça aussi c'est chirurgical, avec d'autres médicaments qui sont associés, des antibiotiques, autre chose.

(41:30 - 42:28)

OK ? Est-ce que vous avez d'autres questions sur autre chose ? Vous avez d'autres questions ? Le séton, c'est quoi ? Alors, le séton, c'est bien de poser des questions comme ça. Le séton, c'est tout simplement l'élastique qu'on utilise. C'est un terme qui est un petit peu plus élégant pour dire élastique.

(42:28 - 42:42)

Parce que, en fait, le matériau du séton, il diffère en fonction des gens, des services, etc. C'est soit un élastique, voilà, soit un lac de chirurgie cardiovasculaire. Mais c'est ça, le séton.

(42:43 - 43:20)

Le séton, c'est le fil ou l'élastique qu'on utilise pour le drainage. Parce que, vous avez vu, dans le cours de la fistule, je vous ai dit, c'est soit on fait une mise à plat, on enlève tout le trajet, c'est l'idéal, soit on pose le séton, on draine, et puis on opère petit à petit pour essayer d'enlever le trajet sans toucher le sphincter. Parce que le principe, en fait, le principe de la chirurgie proctologique, c'est d'opérer, enlever la chose, mais sans toucher le sphincter pour ne pas, bien sûr, donner de ce qu'on appelle l'incontinence anale.

(43:31 - 44:28)

D'autres questions ? Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, sinon, on aura fait un petit peu

le tour de tout. Et on se verra peut-être prochainement. Donc, c'est d'autres questions pour faire autre chose.

(44:32 - 44:48)

Donc, si vous avez des soucis dans quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, si vous avez un responsable. Donc, j'aurai le plaisir de vous répondre ou de régler un problème au cas où. Donc, bon courage et à très bientôt.